核心精讲

其它大肠与肛管疾病

（性感认识：截石位 6 点/膝胸位 12 点）

一、齿状线上下的“两片天地”

内科 其他大肠与肛管疾病&腹外疝1
00:00:00–00:05:29

	齿状线以上	齿状线以下
外科分界	直肠	肛管
演化由来	内胚层	外胚层
本质	黏膜，易破裂出血	皮肤，相对不易破裂
动脉	直肠上动脉（主要）、直肠下动脉、骶正中动脉	肛管动脉
静脉	直肠上静脉→门静脉	直肠下静脉和肛管静脉→下腔静脉
淋巴	肠系膜下动脉旁和髂内淋巴结	腹股沟浅淋巴结
神经	内脏（交感、副交感），痛觉不敏感	躯体（阴部神经），痛觉敏感
癌变	腺癌	鳞癌
痔	内痔	外痔

「串联」
- 直肠癌：从直肠乙状结肠交界处开始，一直到齿状线以上（包括齿状线交界处）的癌

「理顺知识点」
- 齿状线以上的部分本质上是黏膜，主要是柱状上皮，癌变多为腺癌；齿状线以下的部分本质上是皮肤，主要是鳞状上皮，癌变多为鳞癌

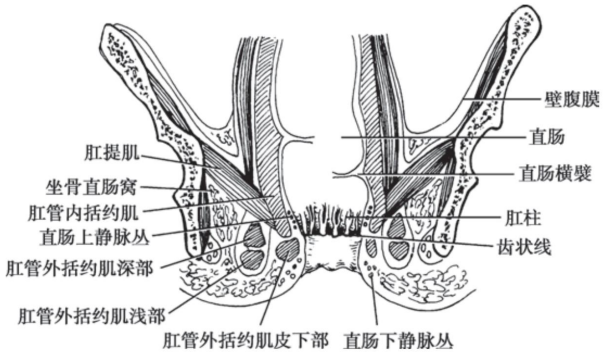


图 41-1　直肠肛管纵剖面图

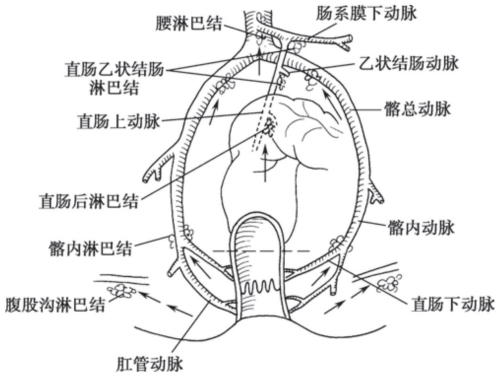


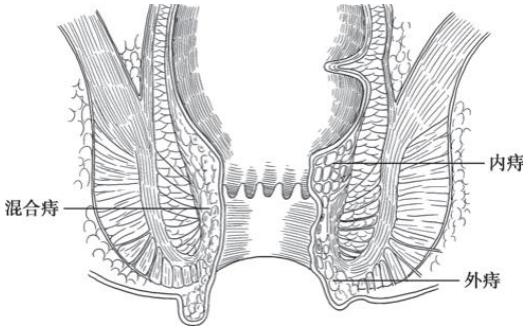
图 41-4　直肠肛管淋巴引流

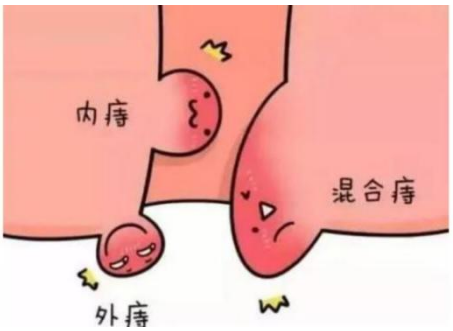
二、痔

内科 其他大肠与肛管疾病&腹外疝1
00:05:29–00:15:54

1.肛垫下移、静脉曲张

2.Ⅲ/Ⅳ度内痔与外痔相互融合为混合痔；环状脱出在肛周呈梅花状为环状痔







3.血栓性外痔：剧痛、暗紫色肿块→剥离痔内血栓

「理顺知识点」
- 外痔的本质是静脉曲张，一旦血栓栓塞就会导致剧痛（不通则痛）

4.内痔



（1）分度（空挡-自动挡-手动挡-挡坏了）

Ⅰ出血（鲜血）

Ⅱ出血+脱出（可自行还纳）

Ⅲ出血+脱出（需用手还纳）

Ⅳ出血+脱出（不能还纳或还纳后再次脱出）

（2）内痔多没有疼痛，若伴血栓、嵌顿、感染可疼痛

（3）截石位 3、7、11 点（姐是打光棍的女生）

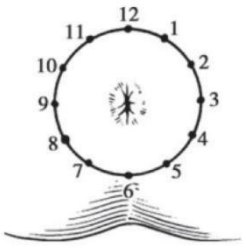


图 41-9　肛门检查的时钟定位记录法(截石位)

「理顺知识点」
- 齿状线以上是黏膜，易破裂出血，齿状线以上对痛觉不敏感，一般无疼痛

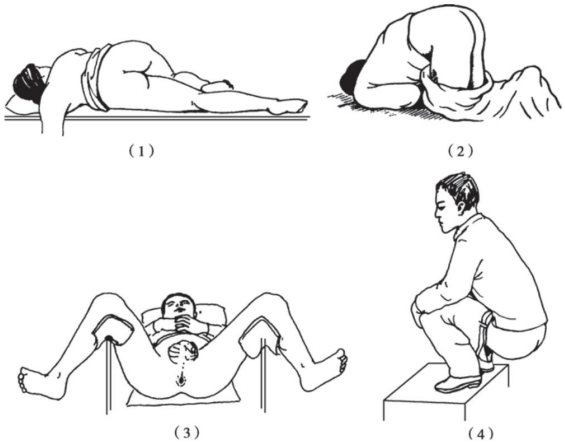
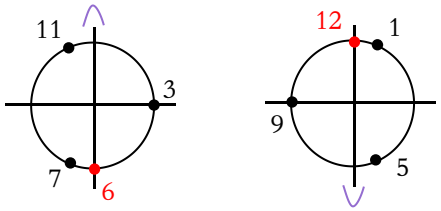


图 41-7　直肠肛管检查体位
(1)左侧卧位 (2)膝胸位 (3)截石位 (4)蹲位



小鸡鸡



内痔：截石位 3/7/11	膝胸位 9/1/5
肛裂：截石位 6	膝胸位 12

幺儿要救我

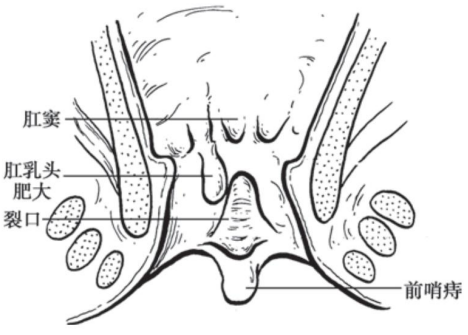


图 41-28　肛裂“三联征”

三、肛裂

内科 其他大肠与肛管疾病&腹外疝1
00:15:54–00:25:53

①肛管皮肤层裂伤后形成的小溃疡

②肛管后正中线：截石位 6 点/膝胸位 12 点（肛门在后面、石榴）。若侧方出现肛裂应想到克罗恩病等肠炎、肿瘤

③多见于青壮年便秘

④排便剧痛→间歇期不痛→肛管内括约肌痉挛痛，多有鲜血

⑤三联征：肛裂、前哨痔/皮垂、肛乳头肥大（前列腺肥大）

⑥首选保守治疗（高锰酸钾坐浴、润便、扩张），无效手术（肛裂切除术、肛管内括约肌切断术、挂线术）

「理顺知识点」

- 肛管后正中线为终末动脉，最易缺血，且肛管后容易受到摩擦，故肛裂好发于肛管后正中线
- 与便秘相关疾病：乙状结肠扭转症（老年人便秘+体位改变）；肛裂（青壮年+“啊！”）
- 内痔 VS 肛裂：
  - 内痔：出血、脱出、一般无痛
  - 肛裂：周期性疼痛（最突出特点）、出血
- 前哨痔：肛裂下方的静脉、淋巴回流受阻，形成局部皮垂
- 便秘会导致疾病恶性循环，需要润便处理
- 扩张：松解肛管内括约肌
- 肛管外括约肌为骨骼肌，受意识支配，控制大便是否失禁；肛管内括约肌为平滑肌，不受意识支配，故肛裂手术只能采取肛管内括约肌切断术

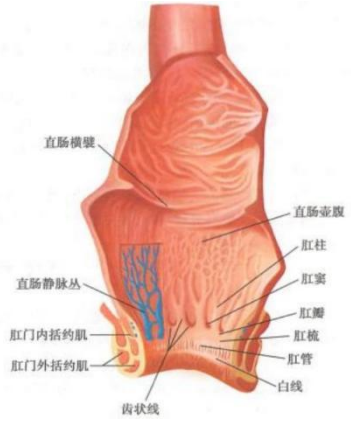
四、直肠肛管周围脓肿

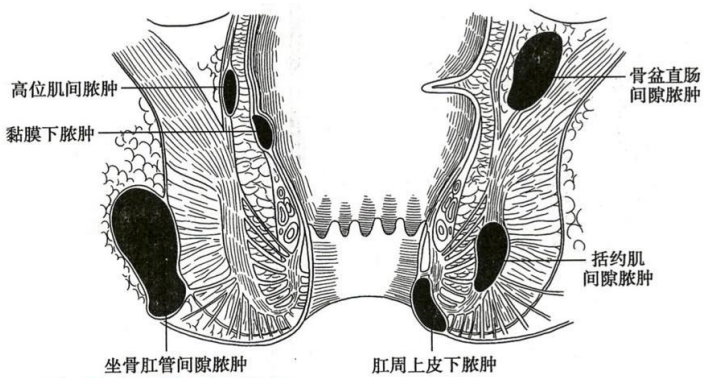
内科 其他大肠与肛管疾病&腹外疝1
00:25:53–00:31:40

触及波动感→切开引流	局部症状（肛周红肿热痛、持续性跳痛）	全身症状（明显发热、血WBC↑）	
肛周脓肿	明显	不明显	最常见
骨盆直肠间隙脓肿	不明显	明显	最少见
坐骨肛管/直肠间隙脓肿	2个　明显	明显	可有直肠和/或膀胱刺激征

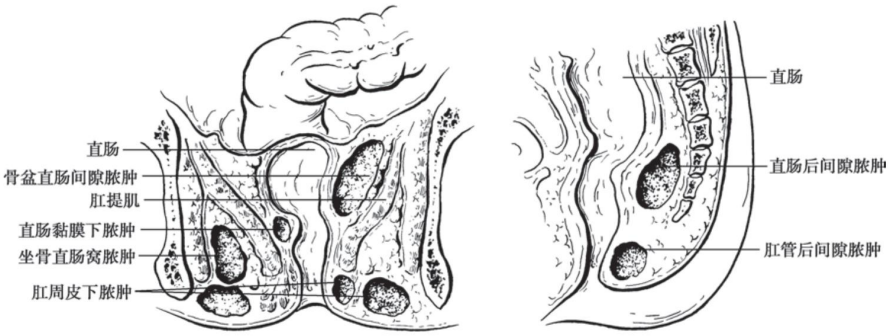
「理顺知识点」

- 越靠近肛门，局部症状越明显；越远离肛门，全身症状越明显
- 坐骨相较于骨盆位置更低





(坐骨直肠间隙脓肿)



图中越靠上全身越重
越往下局部越重
中间的坐骨都明显

内科 其他大肠与肛管疾病&腹外疝1
00:31:40−00:41:25

五、肛瘘（肛周炎症急性期是肛周脓肿、慢性期是肛瘘）

①肛管括约肌间型最常见：瘘管在内外括约肌之间，属于低位肛瘘 我在括约肌之间

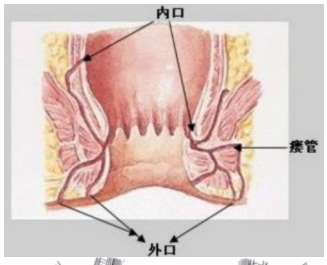
②条索状肿物，反复流出脓血性分泌物

「理顺知识点」
- 瘘管两端相通，反复流出脓血性分泌物

③最重要的是确定肛瘘与肛门括约肌的关系，明确瘘管行程以减少括约肌损伤：

低位单纯	切除肛瘘（首选）、或挂线
低位复杂	切开瘘管（复杂肛瘘有多根瘘管、不可能切除——一大堆屁眼）、或切开+挂线
高位单纯	挂线
高位复杂	切开+挂线

注意：挂线万能，只有低位单纯能切除（直接切除不会损伤括约肌），复杂就要切开



- 高位
- 括约肌
- 低位

一根瘘管就单纯
多根瘘管就复杂

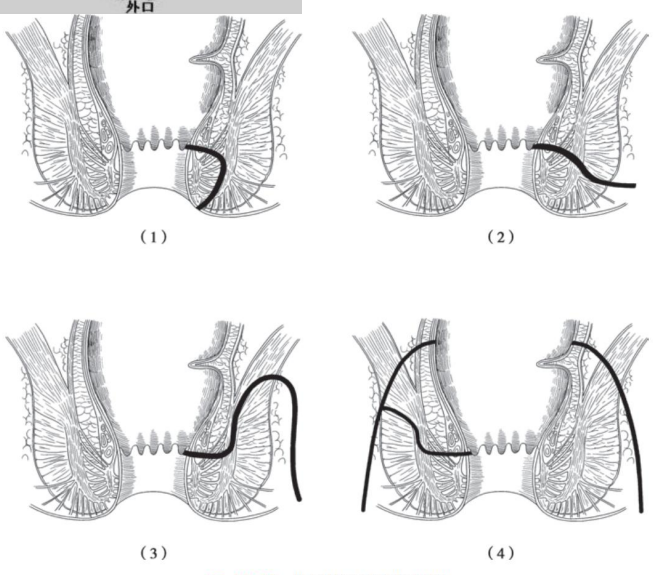


图 41-33　肛瘘的四种解剖类型
（1）肛管括约肌间型　（2）经肛管括约肌型　（3）肛管括约肌上型　（4）肛管括约肌外型

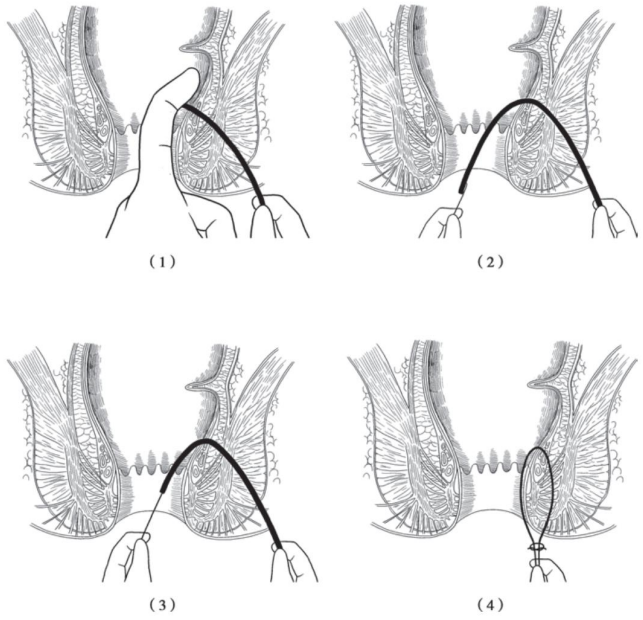


图 41-35　肛瘘挂线疗法
（1）用探针由瘘管外口探入内口，同时手指插入直肠或肛管内　（2）弯曲探针前端，将其拉到肛门口外　（3）探针前端缚一丝线，并接上一橡皮筋　（4）退出探针，把橡皮筋经瘘管拉出，再根据需要行切割或引流挂线

专题串联

直肠指检

内科 其他大肠与肛管疾病&腹外疝1
00:41:25–00:45:24

直肠癌	70%低位直肠癌触及不规则、质硬、易出血肿物
直肠息肉	柔软光滑、可推动的、有蒂、可出血肿物： 内镜下切除息肉
痔	内痔：柔软的血管团
肛瘘	条索状肿物
盆腔脓肿	波动感
前列腺相关疾病	前列腺增生（中间沟变浅或消失）、前列腺癌、前列腺炎等
肛裂	不用

「理顺知识点」

- 直肠指检触及可出血肿物，可能是直肠癌、也可能是直肠息肉



真题解析 · 其它大肠与肛管疾病

内科 其他大肠与肛管疾病&腹外疝1
00:45:24–00:49:13

1.2012N116–117 A　男性，36 岁，肛周持续性剧烈疼痛 2 天，局部有肿物突出，无便血。查体：肛周 1.0cm 直径的肿物，呈暗紫色，表面光滑，水肿，质硬有触痛。 便鲜血优先考虑内痔、肛裂

116.该患者最可能的诊断是

A.肛裂前哨痔

B.血栓性外痔

C.内痔脱出嵌顿

D.直肠肛管黑色素瘤

117.对该患者正确的处理方法是

A.胶圈套扎

B.肿物还纳

C.剥离痔内血栓

D.肿物切除活检

　答案：1 BC

2.2023N163 X　下列关于肛裂的叙述，正确的有

A.大多数位于肛管前正中线 后正中线 肛门在后面，石榴

B.多见于青中年人

C.常与前哨痔、肛乳头肥大同时存在 前列腺肥大

D.常表现为便秘、腹胀 腹胀不常见

答案：2 BC